

2^ο Βαθμού Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός - Mobitz II

- Σε αυτή την περίπτωση το διάστημα PR παραμένει σταθερό πριν και μετά από τους αποκλεισμένους κολπικούς παλμούς. Μπορεί να αποκλείεται ένα κολπικό P (*χαμηλού βαθμού αποκλεισμός - Α*) ή περισσότερα κολπικά P (*υψηλού βαθμού αποκλεισμός - Β*).
- Η αρρυθμία αυτή οφείλεται σε αποκλεισμό του ερεθίσματος συχνά κάτω από το επίπεδο του κολποκοιλιακού (κ-Κ) κόμβου, στο ερεθισματοαγωγό σύστημα του His ή στα σκέλη του, με προοπτική εξέλιξής της σε πλήρη (3^ο βαθμού) κ-Κ αποκλεισμό.
- Ο αποκλεισμός Mobitz II σπάνια εμφανίζεται σε ασθενείς χωρίς δομική καρδιακή νόσο. Η αρρυθμία υποδηλώνει σημαντική δυσλειτουργία (*οργανική ή μόνιμη*) του υποκομβικού συστήματος αγωγής και για αυτό τα συμπλέγματα QRS είναι συνήθως ευρέα.



- Ο ασθενής μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ή να εμφανίζει κλινικά συμπτώματα λόγω υποκείμενης καρδιακής ή μη νόσου που είναι η αιτία του Mobitz II κ-Κ αποκλεισμού (*πρόσθιο OEM, προχωρημένη σκληροεμφυτευτική νόσος του συστήματος αγωγιμότητας - αμυλοείδωση, τοξικός δακτυλιδισμός, όγκος καρδιάς, λέμφωμα, αγγειίτιδα, μυζοίδημα*). Όταν ο κ-Κ αποκλεισμός Mobitz II συνδυάζεται με διαλείποντα πλήρη κ-Κ αποκλεισμό πιθανώς η αρρυθμία να εμφανιστεί σαν επεισόδιο ζάλης ή σαν συγκοπτικό επεισόδιο, εξαιτίας της ανεπαρκούς εγκεφαλικής αιμάτωσης (κρίση Adams-Stokes).
- Στην περίπτωση Mobitz II κ-Κ αποκλεισμού με ρυθμό 2:1, που δεν μπορούμε να τον διακρίνουμε από τον Mobitz I κ-Κ αποκλεισμό, χορηγούνται 0,5 mg Ατροπίνης iv-bolus, οπότε ο ρυθμός Mobitz I μετατρέπεται σε 1^ο βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Εάν ο αποκλεισμός 2:1 συνυπάρχει με αποκλεισμό σκέλους (*ΗΓΚ με ευρέα συμπλέγματα QRS*), τότε είναι πιθανότερο να πρόκειται για αποκλεισμό τύπου Mobitz II.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, σφύξεις (HR), SpO₂, θερμοκρασία).
2. Χορηγούμε O₂ στα 3-8 lt/min, με ρινική κάνουλα ή μάσκα Ventouri, ώστε SpO₂ > 94%.
3. Τοποθετούμε ευρεία φλεβική γραμμή και χορηγούμε ορό 250-500 ml NaCl 0,9%.
4. Χορηγούμε 0,5-1,0 mg **Ατροπίνη** iv bolus, που επαναλαμβάνεται κάθε 3-5 λεπτά, μέχρι την μέγιστη δόση των 3 mg ενδοφλεβίως (δηλ. μέγιστη δόση = 3 amp. Atropine 1 mg). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της Ατροπίνης είναι δόσοεξαρτώμενες και σε ηλικιωμένους ασθενείς μπορεί να προκαλέσει έξαψη, δυσουρία, σύγχυση και αποπροσανατολισμό.
5. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση Ατροπίνης, χορηγείται **Ισοπροτερενόλη**, ήτοι 5 amp. Isuprel/Isoprenaline 0,2 mg/ml, εντός 250 ml D₅W ή N/S, με ροή στις 10-30 μικροσταγόνες ανά λεπτό, με σταδιακή τιτλοποίηση, ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση και την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς (ΑΠ, HR).
6. Εφαρμόζουμε συνεχές ΗΚΓφικό και SpO₂ monitoring και τοποθετούμε στον ασθενή τα ηλεκτρόδια του **εξωτερικού διαδερμικού βηματοδότη - TCP** (και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς), ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση στην περίπτωση που ο καρδιακός ρυθμός μεταπέσει σε πλήρη (3^ο βαθμού) κ-κ αποκλεισμό. Έχει καταδειχθεί ότι η μέση ένταση ρεύματος – *απαραίτητη για την εξωτερική βηματοδότηση* – κυμαίνεται στα 65-100 mA σε ασταθή βραδυκαρδία και περίπου στα 50-80 mA σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς.
7. Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley (14-16 fr), για τον έλεγχο της διούρησης.
8. Ο ασθενής διακομίζεται στο νοσοκομείο, συνοδεύει ιατρού και υπό συνεχές monitoring (ΗΚΓ, ΑΠ, σφύξεις, RR, SpO₂), για περαιτέρω καρδιολογική εκτίμηση και αντιμετώπιση.